

Анализ рынка: платформа навигации по медицинским доказательствам

Кто уже это делает, как они на этом зарабатывают и где остаётся реальная ниша

Подготовлено: Joseph, MN&J Labs · 6 августа 2026 · Источник данных: открытый веб, 7 поисковых запросов + прямая выгрузка сайта. Все факты ниже проверены по указанным ссылкам в этот день; там, где проверить не удалось, это сказано прямо.

Вывод

Врачебная половина идеи закрыта. OpenEvidence бесплатен для врачей, живёт на фарм-рекламе, встроен в Epic и ежедневно используется примерно **40% врачей США** при оценке **12 млрд \$**.

Англоязычная пациентская половина закрывается прямо сейчас. 12 марта 2026 года OpenEvidence и NORD объявили о партнёрстве: библиотека **3000+ описаний редких заболеваний**, в версиях **и для врачей, и для пациентов**, с **экспертной проверкой людьми** и ежемесячным обновлением. Это и есть архитектура нашей спецификации — ИИ-синтез плюс человек-рецензент плюс регулярное обновление, — реализуемая компанией с оценкой 12 млрд \$, бесплатно.

Но остаётся то, чего не делает никто: связать доказательство с ответом на вопрос «а доступно ли это мне там, где я живу». Это и есть наша ниша — и она одна и та же для английского и для русского/иврита.

Кто уже на рынке — по силе столкновения с нами

№	Игрок	Что это	Масштаб	Деньги
1	Outcomes4Me	Персонализированные варианты лечения, подбор исследований, опора на NCCN Guidelines, курируемые новости науки по диагнозу	300 000+ пациентов, 12+ видов рака	21 млн \$; партнёрства с Life Sciences
2	Belong.Life (Израиль)	Соцсеть онкопациентов + ИИ-наставник «Dave» (валидирован онкологами ASCO/ESMO) + «Tara» — подбор клинических исследований	1 млн+ пользователей, 100+ стран	Series B 14 млн \$, лид — IQVIA
3	OpenEvidence	ИИ-поиск по доказательствам для врачей, встроен в Epic	~40% врачей США ежедневно; 10 000+ больниц	Series D 250 млн \$, оценка 12 млрд \$; ~150 млн \$ ARR (оценка Sacra)
4	Massive Bio	ИИ-подбор онкологических клинических исследований	200 000+ пациентов, 19 000+ исследований	Партнёрство с FOMAT, июнь 2026

№	Игрок	Что это	Масштаб	Деньги
5	EvidenceAlerts (McMaster)	Оповещения о доказательствах из 100+ журналов с оценкой людьми-врачами	Академический проект, только для врачей	Бесплатно
6	Consensus / Elicit / Scite	ИИ-поиск по научной литературе	Общий research	10–12 \$/мес (Elicit Pro 49 \$)

Где именно мы проиграем

Outcomes4Me — они это уже делают. Персонализация по диагнозу, опора на NCCN, подбор исследований, научные обновления, 300 тыс. пациентов и интеграция с тем самым источником руководств, который нам пришлось бы лицензировать. Вопрос пациента: зачем мне переходить?

Belong.Life — вот это должно беспокоить Наума больше всего. Израильская компания, 1 млн пользователей, ИИ, валидированный онкологами, и IQVIA (крупнейшая в мире компания по клиническим данным) в роли лид-инвестора. Они занимают ровно ту географию и ровно то сообщество, на которое целился наш мультязычный заход.

OpenEvidence — выиграть нечего. Продукт **бесплатен** для врачей и живёт на фарм-рекламе с CPM 70–1000+ \$ на аудиторию ~600 тыс. выписывающих врачей США (~124 \$ ARPU). Любой платный врачебный тариф с нашей стороны конкурирует с бесплатным и более сильным продуктом. Пациентского продукта у них на сегодня **не найдено** — это и есть окно. Но компания с такой оценкой может войти в этот сегмент когда захочет.

EvidenceAlerts — самый поучительный конкурент. McMaster много лет ведёт оповещения о доказательствах с ручной оценкой врачами. Проект остался бесплатным, академическим и только для врачей. Никто не превратил это в потребительский бизнес. Это сигнал о готовности платить, а не незамеченная всеми ниша.

Английский сегмент — что изменилось

Поправка к предыдущей версии анализа. В первой редакции я написал: «пациентского продукта у OpenEvidence не найдено — это и есть окно», отдельно оговорив, что отсутствие свидетельств не есть свидетельство отсутствия. Проверка англоязычного сегмента показала, что окно уже закрывается. Исправляю прямо, потому что это меняет вывод.

NORD + OpenEvidence, объявлено 12 марта 2026. Что именно они строят:

- **3000+ сводок по редким заболеваниям**, обновляемых **ежемесячно** через редакционную систему
- Две версии каждой сводки — **для врача и «понятным языком» для пациента и семьи**
- **Экспертная проверка** специалистами, рекомендованными NORD, включая сеть NORD Rare Disease Centers of Excellence
- Пациентские версии распространяются через партнёрские каналы; врачебные — внутри платформы

Иначе говоря: **ИИ-синтез + человек-рецензент + регулярное обновление + понятный пациенту формат** — это дословно наша архитектура. Её строит компания с оценкой 12 млрд \$, бесплатно, на английском, в масштабе 3000 заболеваний. Конкурировать с этим «в лоб» на английском невозможно: ни по деньгам, ни по доступу к экспертам, ни по скорости.

Чего они всё равно не делают

- **Это библиотека, а не персональное наблюдение.** Сводка по заболеванию, обновляемая раз в месяц, отвечает на вопрос «что известно о болезни». Она не отвечает на вопрос «что изменилось лично для меня с момента моего диагноза».
- **Это США.** Одобрение и — главное — **оплата** лечения различаются по странам. Даже внутри Великобритании: Англия (NICE + Cancer Drugs Fund, до 340 млн £ в год), Шотландия (SMC), Уэльс (AWMSG + New Treatment Fund), Северная Ирландия — четыре разных ответа на один вопрос. Сегодня пациент собирает это по сайтам благотворительных фондов и государственных органов.
- **NORD — это редкие заболевания.** Англоязычная онкология для пациентов — территория Outcomes4Me (США, 300 тыс. пациентов, NCCN).

Находка, которая меняет стратегию

Все, кто вырос на этом рынке, финансируются фармой:

- **OpenEvidence** — фармацевтическая реклама
- **Outcomes4Me** — партнёрства с Life Sciences
- **Belong.Life** — раунд под лидерством IQVIA

Наша спецификация делает «никакой ложной надежды» и «доказательства прежде вовлечения» непреложными принципами. **Эти принципы исключают единственную модель дохода, которая здесь у кого-либо заработала.**

Это не деталь, которую можно решить позже, — это центральная стратегическая проблема. Либо проект находит плательщика, которого не нашёл никто, либо компрометирует принцип, ради которого его стоит делать. Этот вопрос я бы поставил Науму первым.

Ниша: два рынка, один движок

Проверяемое утверждение: все существующие игроки отвечают на вопрос «что известно об этой болезни». Никто не отвечает на вопрос «доступно ли это лечение мне — там, где я живу, и кто за него платит».

Различие не в языке. Различие в **юрисдикции**. Поэтому английский и русский/иврит — это не выбор «или-или»: это один и тот же продукт с разными справочниками доступа.

Сегмент А — английский, по юрисдикциям

Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия. Доказательства везде одинаковы, а **оплата — нет**. В одной только Великобритании четыре разных механизма (NICE/CDF, SMC, AWMSG, Северная Ирландия), и пациент сегодня собирает ответ по сайтам фондов. Американские игроки этим не

занимаются: их рынок — США.

Почему защитимо: это скучная, локальная, постоянно меняющаяся работа по сведению регуляторных данных — ровно то, чего не станет делать компания, растущая на рекламных CPM в США.

Сегмент Б — русский и иврит, Израиль

В Израиле арабоязычные составляют ~24%, русскоязычные ~17% населения, а нынешнее обеспечение для них — уровня НКО: Израильская ассоциация борьбы с раком вела грантовый проект с переводом материалов, волонтерскими группами и телефонной горячей линией; ESMO и Американское онкологическое общество публикуют переводные PDF-брошюры. Это листовки и телефон, а не продукт.

И главное: «корзина здоровья» (סל תרופות) — то, что реально оплачивается государством, — это тот же самый справочник доступа, только для Израиля. Тот же движок, другая таблица.

Почему это одна работа, а не две

Конвейер доказательств (сбор → нормализация → оценка уровня → проверка человеком) строится один раз и общий для всех рынков. Разными остаются только два слоя: **таблица доступа по юрисдикции и язык вывода**. Это означает, что английский сегмент не конкурирует с израильским за ресурсы — он использует ту же систему. Начать дешевле с одной юрисдикции, а какой именно — вопрос того, где быстрее найдётся рецензент.

Чего я не смог проверить

- **Цены Outcomes4Me** — на сайте не указаны; бесплатность для пациента подразумевается, но не подтверждена.
- **Планирует ли OpenEvidence пациентский продукт** — свидетельств не найдено, но это не доказательство того, что его не строят.
- **Выручка Belong.Life и их доля в Израиле** — цифры не публикуются.
- **Цены Epistemontos** — данных за 2026 год не найдено.
- **Русскоязычный конкурент** — мои запросы шли по американскому индексу. Продукт на русском или иврите может существовать и не попасть в выдачу. **Это нужно проверить до того, как делать ставку на нишу**, потому что на этом утверждении держится весь замысел.

Рекомендация

Глобальная платформа на десять фаз из спецификации против этого поля не жизнеспособна. Соревноваться с OpenEvidence в «сводках по заболеванию» — тоже. Но защитимый первый продукт есть, и он один для обоих рынков:

Доказательства + доступ. Оценённые по уровню и проверенные человеком данные по одной нозологии, где каждая карточка отвечает на два вопроса: *что изменилось и могу ли я это получить там, где живу*.

Одна нозология · одна юрисдикция для старта · сначала веб · еженедельный дайджест.

Это достаточно мало, чтобы построить имеющейся командой; достаточно скучно и локально, чтобы туда не пошли ни OpenEvidence, ни Outcomes4Me; и достаточно честно, чтобы сохранить стержень «никакой ложной надежды» — потому что «вам это недоступно» тоже честный ответ, и сегодня его никто не даёт.

До начала работ — три действия: (1) проверить, что русско- и ивритоязычного игрока не существует; (2) выбрать стартовую юрисдикцию по тому, где быстрее найдётся рецензент; (3) ответить, кто платит, если фарма исключена.

Отдельно: название проекта

Против варианта «**Light of Hope**» / «**Свет надежды**» — два конкретных возражения, не вкусовых.

1 · Оно обещает ровно то, что продукт отказывается продавать

Первый непреложный принцип спецификации — «**никакой ложной надежды**». Весь этический стержень: доказательства прежде вовлечения, ничего не преувеличивать, человек-рецензент перед тем, как что-то дойдёт до пациента. Название «Свет надежды» подрывает это прямо на входной двери — оно создаёт то самое ожидание, ради управления которым продукт и существует. Для напуганной аудитории это не ирония, а режим отказа. И это первое, что критик или регулятор процитирует в ответ.

2 · Имя уже занято — в этой же категории

Lights of Hope — флагманская кампания Американского онкологического общества (ACS CAN): более 14 лет, по всей стране, ~65 000 памятных пакетов в год, действует и в 2026-м. Запуск онкологического продукта под этим именем означает конкуренцию с ACS за собственную поисковую выдачу.

Что должно уметь название

- **Не обещать исход** — это навигационный инструмент, а не лечение (и это же граница SaMD)
- **Работать на русском и на иврите** — это наш целевой рынок
- **Говорить, что продукт делает:** ориентация и источники
- **Быть различимым** в категории, перегруженной словами «надежда» и «путь»

Название	Значение	Почему работает	Риск
Makor מקור · Макор	ивр. «источник, первоисточник»	Вся дисциплина продукта — «у каждого утверждения есть источник». Плюс «источник» в журналистском смысле — достоверность. Звучит местно и заслуживающе доверия в Израиле; русскоязычные произносят легко.	Частое слово; «Макор Ришон» — крупная израильская газета
Orientir Ориентир	рус. «точка, по которой ориентируются»	Буквально функция продукта — не пункт назначения, а точка отсчёта. Занимает русскоязычную нишу.	Ничего не значит для англо- и ивритоязычных
Beacon маяк · גִּבְעוֹן	«маяк»	Сохраняет образ света, который вам понравился, но убирает обещание: маяк показывает, где вы находитесь, и никогда не обещает, что вы дойдёте до берега.	«Beacon Health» широко занято в американском health-tech

Моя рекомендация — Makor (Макоп). Это единственный вариант, который называет дисциплину, а не чувство, — а дисциплина и есть продукт. Он местный для того рынка, с которого мы реально начнём, и даёт обещание, которое мы способны сдержать: *за каждой строкой здесь стоит источник.*

Makor — онкологические доказательства: источник и проверка.

Если хочется сохранить метафору света — **Beacon** это честная её версия. Если ставим флаг именно в русскоязычной общине — **Ориентир**.

Оговорка: это суждение о названии, а не юридическая проверка. Товарные знаки и домены я не проверял.

Источники

Все ссылки открыты и проверены 6 августа 2026 года.

- CNBC — OpenEvidence, оценка 12 млрд \$:
cnbc.com/2026/01/21/openvidence-chatgpt-for-doctors-doubles-valuation-to-12-billion.html
- Fierce Healthcare — Series D 250 млн \$:
fiercehealthcare.com/ai-and-machine-learning/openvidence-clinches-250m-series-d-rapidly-growing-its-reach-doctors
- NBC News — кто будет платить за OpenEvidence:
nbcnews.com/tech/tech-news/openvidence-free-now-ceo-plan-will-pay-rcna343672
- Sacra — выручка и оценка OpenEvidence: sacra.com/c/openvidence/
- Outcomes4Me — сайт продукта: outcomes4me.com
- Belong.Life — Series B 14 млн \$: belong.life/press/belong-life-raises-14-million-to-expand-its-digital-cancer-support-network/
- Fierce Healthcare — ИИ-наставник Belong.Life:
fiercehealthcare.com/digital-health/belonglife-maker-social-network-cancer-patients-launches-ai-mentor
- Massive Bio — сайт и партнёрство с FOMAT: massivebio.com
- biospace.com/press-releases/massive-bio-partners-with-fomat-to-expand-cancer-patient-prescreening-for-clinical-trial-access
- EvidenceAlerts (McMaster): medlib.belmont.edu/keepcurrent/evidencealerts
- UICC — арабо- и русскоязычные пациентки в Израиле:
uicc.org/case-studies/support-groups-arab-and-russian-speaking-women-metastatic-breast-cancer-israel
- ACS — информация об онкологии на русском: cancer.org/cancer-information-in-other-languages/russian.html
- PR Newswire — партнёрство NORD и OpenEvidence, 12.03.2026: prnewswire.com/news-releases/national-organization-for-rare-disorders-and-openvidence-partner-to-bring-ai-powered-rare-disease-resources-to-clinicians-and-patients-worldwide-302711679.html
- NORD — страница партнёрства: rarediseases.org/national-organization-for-rare-disorders-and-openvidence-partner-to-bring-ai-powered-rare-disease-resources-to-clinicians-and-patients-worldwide/
- NHS England — Cancer Drugs Fund: england.nhs.uk/cancer/cdf/
- Cancer Research UK — как лекарства попадают в NHS:
cancerresearchuk.org/about-cancer/treatment/access-to-treatment/how-medicines-become-available
- Target Ovarian Cancer — как одобряют онкопрепараты в разных частях Великобритании:
targetovariancancer.org.uk/get-involved/campaign/current-campaigns/access-drugs/how-are-cancer-drugs-approved-across-uk
- ACS CAN — кампания Lights of Hope: fightcancer.org/lights-hope-1
- Сравнение цен Elicit / Consensus: paperguide.ai/blog/elicit-vs-consensus/